

8 - 02.2- Fractures mandibulaires - Pr. Mansouri

Bonjour tout le monde, je ne me rappelle pas à quel niveau on a arrêté le cours des fractures mandibulaires, la dernière fois, l'avant-dernière fois. On avait commencé le cours sur les fractures mandibulaires, vous vous rappelez ? Donc on s'est arrêté où ? On a fait l'anatomie ? On a commencé l'examen clinique, c'est ça ? Pas encore. Là, on s'est arrêté ici ? On a fait les classifications ? Bien, donc je vais quand même revenir sur l'anatomie pour revenir aux classifications.

Vous savez que la subdivision de l'anatomie, c'est la subdivision des formes cliniques, c'est la même chose. Donc si on connaît un petit peu de quoi est constituée la mandibule, qui est d'abord le corps, qui est la partie dentée de la mandibule, c'est la partie qui porte les dents, et le ramus qui correspond, je ne sais pas si ce micro marche, c'est plus simple pour moi. Voilà donc la subdivision de la mandibule.

Vous voyez la subdivision de la mandibule, donc nous avons le coroné à ce niveau-là, ou le processus coronoïde, le condyle ou le processus condyloïde. Trois, c'est l'abramentement de tente et quatre, c'est l'angle mandibulaire. Nous avons la région alvéolaire, celle qui porte les dents, et la région symphysaire et la branche horizontale.

Si on revient toujours à l'anatomie, c'est que nous avons une bonne partie de la mandibule qui est traversée par un nerf. C'est le nerf mandibulaire et qui se termine au niveau de la canine. Ce qui fait au niveau de la subdivision, je vous pose la question, s'il y a une fracture en avant du nerf dans la région symphysaire, est-ce qu'il y aura une hypoesthésie, la biomentonnière ? Je repose la question, je m'explique.

Le nerf dentaire traverse, ou le nerf mandibulaire traverse la mandibule au niveau de la face interne, et sur toute la mandibule, il se termine au niveau de la canine, à ce niveau-là. Si on va revenir au schéma, le nerf dentaire se termine, d'ailleurs ici il a été retiré, il se termine ici. Donc, toutes les fractures qui vont siéger sur le trajet du nerf vont entraîner une compression du nerf.

Vous êtes d'accord ? Je passe au schéma. Regardez, si j'ai une fracture à ce niveau, ou à ce niveau, ou à ce niveau, est-ce que vous suivez ? Sur le trajet du nerf, est-ce qu'il sera comprimé ? Oui, automatiquement. Si la fracture passe perpendiculaire par rapport au nerf, sur son trajet.

Et si la fracture est en dehors du nerf, est-ce que le nerf risque d'être comprimé ? Non, bien sûr. Et la compression va induire ce qu'on appelle l'anesthésie, la biomentonnière, ou l'anesthésie de la région qui est intéressée par la fracture. Or, la classification des fractures va être en fonction de l'anatomie, qu'on vient de voir maintenant.

Donc là, par exemple, quand on parle de la canine et la canine, ça s'appelle comment cette région ? Région symphysaire. Et entre la canine et la moellaire, ça s'appelle quelle région ? Branche horizontale. Branche horizontale, on est toujours dans la partie dentaire.

Donc nous avons de chaque côté une branche horizontale entre la canine et l'angle mandibulaire. Voilà, la canine et l'angle mandibulaire. Et la portion qui est entre les deux canines s'appelle la région symphysaire.

Mais quand c'est droite, on l'appelle parasymphysaire. Quand c'est gauche, on l'appelle parasymphysaire gauche. Donc parasymphysaire gauche, parasymphysaire droite.

Donc si on reclasse nos fractures, ici, ça s'appelle comment cet élément ? Candyle. Donc les fractures, elles sont dites candyliennes. Et cet élément s'appelle comment ? Le coronet.

Donc là, on parle des fractures du coronet. Là, la branche montante. Vous avez vu ? Ça s'appelle fracture de la branche montante.

Donc on est en train de copier l'anatomie sur la clinique. Donc si on regarde ici, elle est à quel niveau la fracture, là ? L'angle mandibulaire, elle est au niveau de l'angle. Voilà la division.

Voilà. Là, c'est la région de l'angle mandibulaire. Voilà le candyle, le coronet, la branche montante, l'angle, la région de la branche horizontale entre la canine et la dent de sagesse.

Et la partie antérieure vers le montant, ça porte le nom de symphyse ou fracture symphysaire. Et si elles sont en droite, on dit parasymphysaire droite. Si elles sont en gauche, on les appelle parasymphysaire gauche.

Et si on revient à la classification, et on va regarder les images ici, cette fracture ici, à quel niveau elle siège ? Elle est au niveau de l'angle, mais aussi, comme elle est en-dedans de la dent, c'est une branche horizontale. Et cette fracture-là qui rase la canine, c'est une parasymphysaire. Ici, c'est une fracture de l'angle.

Et là, on ne voit pas très bien parce que le scanner est caché. Donc, on va y revenir de toutes les façons. Donc, la fréquence, elles sont très fréquentes, ces fractures.

Elles relèvent de l'agression, mais ça peut être aussi un autre type de fracture. Alors, toujours, toujours, quand on est en traumatologie du bras ou de la face, on fait d'abord un examen général sommaire et ensuite l'examen fixé sur la région. Quand c'est une épaule, on examine l'épaule.

Quand c'est une face, c'est le maxillofacial. Et c'est toujours complet, comparatif, bilatéral, avec un bon éclairage et un aveuse longue. Complet et comparatif parce qu'on appelle la face entière, mais en fait, nous avons deux hémifaces.

C'est comme si on a une face droite et une face gauche. Parce que quand vous voyez les membres, on a une main droite et une main gauche. Vous êtes d'accord ? Mais quand on regarde le visage, il porte un seul nom, la face.

Mais en fait, la face est dupliquée. Il y a une pommette droite, une pommette gauche, le doigt

gauche, la narine droite, la narine gauche. Donc, on a finalement deux hémifaces.

Donc, l'examen, à chaque fois que vous avez deux portions dans un corps, on fait un examen bilatéral. Quand il y a les membres, on dit examen bilatéral. Comparatif, c'est pour comparer le côté droit au côté gauche.

Bon, c'est un examen qui est comparatif, bilatéral et stéréotypé. Alors, quand on fait l'interrogatoire, nous allons, comme d'habitude en traumatologie, chercher la date du traumatisme, les circonstances et le point d'impact. Il sert à quoi ? Dans la fracturologie de la mandibule, de connaître le point d'impact.

Je vais vous expliquer parce que je ne vous l'ai pas mis ici sur le cours, ça va alourdir le cours. C'est que la mandibule, elle a des zones de faiblesse. Parmi les zones de faiblesse, c'est les zones candyliennes, les zones de l'angle.

C'est les zones qui sont fragiles. Et quand on envoie un coup de poing sur la menthe, quelles sont les zones qui vont céder en premier ? C'est les candyles. Quand le patient vous dit j'ai reçu un coup de poing sur le mentant ou vous trouvez une plaie sur le mentant, allez chercher des fractures candyliennes.

Le coup est sur le mentant, mais la fracture, elle est dans le candy. Un autre type de direction de choc, vous recevez un choc phare. Le patient ne sait pas où.

Il reçoit un coup sur l'angle droit et la fracture, elle est sur l'angle gauche. Vous comprenez ? C'est les fractures plus radiales, c'est les chocs plus radiaux. C'est une spécificité de la mandibule.

C'est pour cela qu'on le dit, toute plaie sur la région mentonnière doit avoir recherché systématiquement une fracture candylienne. Ceci est très vrai pour les enfants parce que les petits tombent et ne se protègent pas. Ils n'ont pas suffisamment de bons réflexes de protéger leur visage.

Les enfants, les petits, ils vont tomber sur le mentant, surtout les chutes de bicyclette, tout type de chute. Cela fait fracturer les fractures candyliennes. Les fractures de la face, d'une manière générale, ne sont pas douloureuses.

Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous savez que les fractures faciales ne sont pas douloureuses ? Une fracture du malheur, quel type d'anesthésie elle donne ? Infraorbitaire, ici, à cause du 5.2. Une fracture frontale qui rase le 5.1, elle donne une anesthésie frontale. Une fracture de la mandibule, à part les symphysères, elle donne une anesthésie. Donc, il n'y a pas une scène de douleur comme la fracture candylienne, du fémur par exemple.

Vous voyez les patients en traumatologie, quand vous êtes de garde aux urgences, ils sont toujours en train de hurler et de crier, et de gémettre. Vous le savez ça. Aïe, aïe, aïe, aïe.

Ils ne font pas la scène, ils ont très mal. Parce que l'innervation proprioceptive des articulations est très importante, et la fracturologie des membres est très, très, très douloureuse. Nous, en fracturologie faciale, il y a des anesthésies.

Quand il y a une fracture, il y a une compression des nerfs, et donc les patients ne sentent pas beaucoup. Donc, il peut avoir une fracture et rentrer chez lui. La douleur, il y a qui mène le patient à consulter, qui le ramène vers nous aux urgences.

Donc, à cause de cela, un enfant peut chuter. Oui, j'ai des urgences. Vous suturez les points de suture.

Vous l'appellez montonnière, il rentre chez lui, et on n'a pas vérifié le condyle. Mais la fracture, elle est condylienne, peut-être. C'est pour cela, quand vous êtes dans vos cabinets, ou vous êtes dans une clinique, par exemple, la maman vous ramène un petit, il pleure, il y a du sang.

On est impressionné par le sang. Vous tamponnez, vous suturez. Mais il faut réexaminer les régions de l'articulation temporomandibulaire.

D'accord? Comment vous vous appelez-vous? Meryem. Docteur Meryem, elle est aux urgences de l'hôpital Ibn Tufayl. Elle est de garde.

Il y a une maman qui arrive de l'école, parce que souvent, réfléchissez, vous me demanderez ça. De l'école, l'école appelle la maman, elle ramène le petit. Ça, c'est énormément sur le menton.

La selle, c'est comme ça que le malade vient. Le malade ne vient pas une femme. La clinique est écrite sur le peau.

Et puis, Docteur Meryem, elle a vu le sang, ça lui a fait peur. Le sang, ça fait peur, bien sûr. La maman taille, elle hurle.

Sa mère, elle hurle. Tout le monde crie. Bon, Docteur Meryem, les infirmiers, elle a mis ses points de suture, elle a pris la photo, elle a fermé, elle est sortie voir la mère, elle lui a dit, je vais faire l'esthétique.

Est-ce que Docteur Meryem a fait son travail? Est-ce qu'elle a fait son... Je veux entendre. Non. Parce que Docteur Meryem, elle a raison.

L'enfant, il crie, il hurle. Bien comme pour moi, la maternité est la même. La maman, tu sais, c'est mon fils.

Je vous le dis Donnez-lui des antibiotiques, des anti-inflammatoires, vaccins, anti-tétaniques, etc. Mais Docteur Meryem n'a pas fait son travail. Elle devrait prendre les index, les mettre en préauriculaire et vérifier s'il n'y a pas de douleur, mettre les doigts dans le condyle, ouverture,

fermeture.

Et au moindre doute, normalement chez l'adulte, c'est la radio panoramique, mais chez l'enfant, elle fait un scan. Pourquoi? À l'âge de Docteur Meryem, à l'âge de l'enfant, il a l'air satisfait. Quel est le risque d'une fracture fondulienne chez l'enfant? Qu'est-ce que ça risque de faire chez l'enfant? Pourquoi je me suis arrêtée carrément? Le candyle mandibulaire, comme le candyle huméral, comme le candyle... C'est un centre actif de croissance.

C'est-à-dire l'allongement de l'os, qu'il soit humérale, qu'il soit fémur, que ce soit mandibule, il dépend de ce centre chondral qui cartilagine dans l'ensemble, parce que c'est un petit. Elle lui a ramené son fils de 5 ans. Et s'il y a une fracture et de l'hémorragie, le centre actif va stopper la croissance.

Et un, il risque de coller et de créer une onkylose. Il risque d'y avoir une soudure à ce niveau-là. Et si c'est bilatéral, c'est une soudure bilatérale.

Et donc ça crée une impossibilité d'ouvrir la cavité buccale. Donc, alimentation, caries dentaires, inaccessibilité à l'examen, il a arrêté. On va vous faire cela en cinquième année.

Et la deuxième semestre, je crois qu'on est en premier semestre. Deuxième semestre, je vous ferai la sémiologie, on en reparlera. Et donc, cette onkylose, elle va retentir sur la croissance.

Si c'est unilatéral, il va dire, il faut moins rouge, tirer de l'autre côté. Si c'est bilatéral, il va avoir une petite mandibule avec un maxillaire en avant. C'est très dysmorphique.

Donc, il faut faire la prévention. Il faut rechercher les fractures mandibulaires par docteur Amélie, par l'examen clinique et par un scanner, parce que c'est un enfant. Et si c'est un adulte, on lui fait une radiopantomique, un orthopantomogramme.

Et on cherche les fractures que le chirurgien maxillofacial va pouvoir traiter, lui faire la rééducation, une limitation de l'ouverture buccale et une onkylose. Donc, toute plaie sur le menton doit faire rechercher une fracture mandibulaire. Les antécédents de l'asthme, l'épilepsie, le diabète lors du dernier repas et les signes fonctionnels que sont Quels sont les signes fonctionnels? Les signes fonctionnels vont dénoter le rôle de l'articulation de l'os.

Par exemple, l'épaule. La fonction de l'épaule. Qu'est-ce que dit l'épaule? Abduction, abduction, écartement.

Donc, s'il y a une fracture, il va y avoir une limitation de l'abduction. Rotation de l'épaule, limitation de la rotation. Donc, les signes fonctionnels en fracturologie, c'est la limitation du mouvement physiologique de l'articulation plus la douleur.

Donc nous, comme toute fracture, vous allez rechercher par les signes fonctionnels si le patient se plaint de douleur malgré qu'on sait que dans les fractures faciales, il y a très peu de douleur à

cause de l'anesthésie. Ça veut dire que l'absence de douleur n'élimine pas la fracture. Limitation de l'ouverture buccale parce que le rôle de la mandibule c'est l'ouverture buccale.

Est-ce que c'est le maxillaire qui ouvre la bouche? Pourquoi? C'est un os. Il est fixe. Il ne bouge pas.

Et quel est l'os mobile? C'est la mandibule. Donc, s'il y a une fracture mandibulaire, il va y avoir une limitation de l'ouverture buccale. Quels sont les autres rôles de la cavité buccale et de la mandibule? C'est respiratoire, bien sûr.

C'est l'élocution. C'est la dilatation. Et donc, le patient qui a une fracture de la mandibule, il a une allure.

Et donc, il a une... Excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai dit le deuxième semestre. Je croyais que j'enseignais à la deuxième année. Là, on a trouvé de la mandibule.

J'ai affaire à la cinquième année, donc il n'y a pas de deuxième semestre. Donc, les gènes, c'est les gènes qui sont liés à la fonction. Est-ce que vous êtes impatient de finir? Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Même si c'est le début de l'année? Qu'est-ce qui vous fatigue? Vous êtes naturellement fatigué? Qu'est-ce qui vous fatigue? Oui.

Pourquoi vous êtes fatigué toujours? Toi, tu n'es pas fatigué. Quels sont ceux qui sont fatigués? Lève les doigts. Honnêtement, ceux qui sont fatigués.

Je vais parler à ceux qui sont connectés, les quelques-uns qui sont connectés. Et ceux qui sont connectés, quels sont ceux qui sont fatigués? Je vais voir ici. Ils me disent oui, oui, oui sur la discussion.

Quels sont ceux qui sont fatigués? Non, non, ils ne sont pas fatigués parce qu'ils sont chez eux, ils regardent autre chose. Combien d'eux? Je vais voir combien. Non, ils disent non, ils disent non.

Honnêtement, il faut être honnête, il faut dire oui. Non, non, non, oui, oui. Il y a des oui, hein.

Il y a des oui qui sont fatigués. Ils ont raison. Donc juste moi, je pose la question.

Qu'est-ce qui vous fatigue, les étudiants? La chaleur? C'est normal, oui. Mais il y a autre chose qui vous fatigue, à part la chaleur. Quoi? Mais je veux venir vers les étudiants.

Moi aussi, je suis fatiguée. Parce que les étudiants m'ont transmis leur fatigue, même s'ils ont l'âge de mes petits-enfants. Dites-moi pourquoi vous êtes... Qu'est-ce qui vous fatigue? Ah, je... Le fait de vouloir... Il y a trop de choses à faire pendant la journée.

Il y a le service le matin, après on vient au cours, après il faut aller à la salle, après revenir pour voir les cours, après si on a les gardes et vouloir faire tout ça, enfin, c'est fatiguant. Est-ce que

tout le monde partage son avis? Oui. Oui, oui.

Est-ce que vous dormez suffisamment? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Vraiment, le stress. Vous êtes stressé? Pas trop? Non, pas trop. Qu'est-ce qui vous prend à ne pas dormir le soir? Qu'est-ce que vous faites pour vous empêcher de dormir les étudiants? Tu dors très bien le soir, donc tu n'es pas fatigué maintenant.

Pas trop. Ceux qui ne sont pas occupés par le téléphone, je veux qu'ils aient le courage de dire oui. Levez le doigt.

Levez la main. Les autres n'en ont pas tous, ceux-là n'ont pas le téléphone, ils ne l'utilisent pas. Donc, c'est des menteurs et des menteuses, donc je ne les crois pas, bien sûr.

Eh bien, le téléphone vous fatigue, bien sûr. Quand on fait deux heures en regardant le téléphone, la lumière, la réflexion, ça détend et ça fatigue énormément. Si vous pouvez dormir et faire vos heures de sommeil, vous organisez, vous serez bien.

Mais bon, c'est un fléau qui vous dépasse. Est-ce qu'on ne peut pas vous enlever le téléphone? Vous détendre. Oui, mais on ne s'amuse pas dans la semaine.

On s'amuse les week-ends. Pas toujours. Vous ne faites pas des gardes chaque semaine, ma fille.

Je suis à la fac depuis, je crois, 1992. Cela fait plus de 31 ans que j'enseigne et j'ai vu des générations et des générations. Vous n'êtes pas de garde toutes les semaines, non? Non, les week-ends.

Une garde sur cinq. Le service de Maxilo, une garde sur cinq, c'est un service fatigant, Maxilo. C'est très fatigant parce que dans le box, ils travaillent.

Parce que nous, on est entre le marteau et l'enclou. Soit créer de l'activité pour les externes et les former et les impliquer parce qu'on les considère des médecins ou bien on les laisse dormir et ils font ce qu'ils veulent. Vous choisissez.

Vous apprenez dans le box. Vous voulez que je vous montre une suite sur GFI? Parce que parmi mes objectifs de créer cette discipline, c'est d'apprendre aux médecins de suturer et de rendre service à la nation, aux citoyens, et de leur apprendre. De toute façon, en sixième année, on vous fait un atelier d'une semaine sur la suture.

Comme ça, tout le monde apprend. Mais quand tu finis ta garde, tu es content. Tu as une satisfaction.

Le sommeil pour nous, les médecins, est très important. Parce que parmi vous, certains vont faire des métiers de chirurgie chaude, enfin des métiers, des spécialités chaudes. Réanimation,

gynécomestique, cardio, etc.

Et nous avons choisi, attention, nous avons choisi de ne pas nous détendre tout le temps. C'est un choix. Parce que le jour où on a choisi de venir faire les études médicales, nous avons choisi de ne pas vivre comme les autres.

On n'a pas de jour férié, on n'a rien. On travaille, on soigne les gens tout le temps. Mais quand on est bien organisé, on peut créer des lapses de temps de repos.

Ça, c'est clair. C'est une histoire d'organisation. Et normalement, vous, vous êtes en cinquième année, vous êtes suffisamment rodé pour pouvoir vous organiser.

C'est les troisième année, normalement, qui sont très fatigués, parce que c'est la première année où ils font l'hôpital le matin et le cours l'après-midi. Et les cinquièmes années, généralement, ils sont bien structurés, bien reposés. Ce n'est pas pareil comme les autres années.

Et puis, ceux, les quelques-uns qui sont à l'amphi, généralement, c'est les plus motivés. C'est ceux qui veulent assister, les savants, vous connaissez. Ceux qui ne s'absentent jamais, ils sont toujours à l'amphi, tout ça.

Donc, c'est un peu surprenant sur une promotion de 400 étudiants, par exemple, avec un paquet de 50 étudiants qui sont à l'amphi. parce qu'on trouve 80 % parmi eux qui sont fatigués. Donc, vous devez réviser votre mode de vie, parce qu'à votre âge, vous ne devrez pas être fatigué.

Vous êtes jeune. Si vous êtes bien organisé, vous devez être très en forme, normalement. Et ça, moi, je sais pourquoi, parce que si il y a un fléau, c'est le téléphone.

Le téléphone, il en est pour quelque chose, parce que vous regardez, vous avez l'impression de vous détendre, mais finalement, il vous prend votre santé et votre vie. Vivez l'expérience de ne plus le regarder à partir de 10 heures du soir et qu'à 10 heures et demie ou plus tard, vous êtes dans le lit. Et réveillez-vous très tôt.

Faites du sport si vous pouvez ou faites n'importe quoi chez vous et venez à l'heure sans courir et essayez cette expérience d'une semaine et revenez vers moi pour me dire si c'est pas le téléphone qui est la cause. Je le sais. Parce que moi, je n'aime pas le téléphone.

Il y a un moment, je me suis dit, tout le monde sur les réseaux, il regarde. Et dès que je me mets à regarder ça, mais puis, ça me prend du temps. Ça vole ma vie et ça vole mon temps.

Non, je ne dois pas être esclave du téléphone. Non. C'est un esclavage qui détruit votre santé.

Je vous le dis, hein. Ma chérie, elle a dit, non, c'est, ils volent votre temps. Et le temps chez vous, nous, les médecins, le temps est très précieux pour nous parce que dans le temps, on se repose.

On a besoin. Vous allez vivre ça toute votre vie. Toute votre vie, vous allez toujours être partagé

entre les cliniques, entre l'hôpital, même si vous n'êtes pas professeur.

Vous avez un cabinet médical qui travaille du matin au soir. Toujours, il y a le malade. Et donc, votre corps doit se reposer.

Très important, les étudiants en médecine, malheureusement, la faculté ou les facultés de l'université n'offrent pas un espace de détente réelle de sport, de culture, d'écriture, de peinture, de musique, de, de, de, de. Donc, les capacités dont vous disposez parce que vous êtes des élites, vous êtes très intelligents. Vous avez un espace cérébral énorme.

On peut mettre plein de choses. Vous pouvez, vous êtes capables de faire trois études parallèles. Ça, je ne doute pas.

Au contraire, c'est, on n'utilise qu'une partie de votre cerveau dans les facultés d'une manière générale. Et là, on n'a pas les moyens de vous mettre des vrais moyens de distraction pour vous détendre. Les vrais, ce n'est pas le téléphone.

La distraction, c'est la peinture, c'est l'écriture, c'est le sport, c'est la poésie, c'est la musique, c'est la poterie, c'est plein de choses. Mais c'est ça qui vous coupe avec le milieu médical, ce milieu qui va vous suivre toute une vie et qui est triste, qui est difficile, qui est douloureux, qui est pénible. Ce n'est pas facile d'être toujours avec les malades.

Vous allez le faire toute votre vie. Et donc, si aujourd'hui, en cinquième année, vous n'êtes pas conscient de trouver une solution de détente réelle qui vous accompagne toute votre vie, vous allez être toujours fatigué parce que vous allez virer vers les choses qui sont mauvaises pour vous détendre. C'est ça.

Vous allez résident, finir le résidentat, vous allez être chirurgien, réanimateur, etc. Et quand vous allez finir à cinq heures de l'après-midi ou à sept heures de votre travail, qu'est-ce que vous allez faire? Quoi? Le quoi? Quoi? Vous devez penser dès aujourd'hui à une distraction qui va vous détendre réellement et qui sera un compromis pour vous reposer, pour aller rejoindre vos familles, pour que le lendemain soit un jour meilleur. Parce qu'on n'a pas le droit d'être malade.

On doit être en forme pour soigner les gens. Encore est-il, nous l'avons choisi. Est-ce qu'on vous a obligé de faire des études médicales? Est-ce que vous avez été obligé de faire des études médicales? Vous avez tout fait pour faire des études médicales.

Vous êtes battu pour être premier, pour passer le concours. Dans la distinction, vous avez rêvé de porter la blouse. C'est pas facile de faire.

C'est une lourde charge. Assumez, mais préservez vos corps. Pensez à votre corps et à votre santé.

Votre santé, notre santé, toutes les médecins, est précieuse. Parce que le patient, il a besoin de

nous pour le soigner. Et on va détenir un savoir énorme.

Comme ça, quand le patient vient nous poser la question, vous passez l'examen, vous êtes aux urgences, vous recevez une fracture du ventre, vous devez être suffisamment vigilant et en bonne santé pour donner la bonne solution, pour donner le bon soin, pour ne rien oublier. Et on a la santé, on a le sport, on a les distractions qui sont utiles pour le corps et pas les distractions destructives. L'alcool, la cigarette, le téléphone, c'est une addiction.

Toutes les addictions sont mauvaises pour notre corps. Parce que notre corps ne nous appartient pas. Nous appartenons au patient.

Vous comprenez ? Vous n'allez pas faire un petit métier. Vous allez faire un grand métier. Donc, on revient à la fracture mandibulaire.

On ferme la parenthèse. Donc, toute plaie sur le menton doit faire rechercher une fracture mandibulaire chez l'enfant ou chez l'adulte. Je ne sais pas si j'ai ouvert cette parenthèse, mais je dois le dire.

J'espère que les autres aussi entendent. Regardez vos collègues, ce qu'ils ont dit. Le rythme accéléré, les stages.

Oui, beaucoup. Oui, oui, oui. Ils sont tous fatigués aussi.

La majorité, ça les fatigue. Les études médicales fatiguent. Ils sont comme vous.

C'est la même chose. Mais je crois que c'est une histoire aussi d'organisation. Vous devez être bien organisé.

Voilà. Bien. Donc, voilà.

On passe. C'est un problème au niveau de... Voilà. Donc, ça c'est... Je vais rester en mode... Comme ça c'est mieux.

Comme ça je passe vite. Donc, l'examen maxillofacial inspection, le DEMP de l'étage inférieur. Vous allez recevoir un patient qui tient à sa bouche et qui salive et qui n'arrive pas à fermer sa bouche.

C'est sa latitude. Le blessé garde la bouche ouverte. Un aspect très évocateur.

On peut avoir un aspect, une asymétrie faciale déformation, soit une déviation du menton qui est dite latérogénie, soit recul du menton qui s'appelle rétrogénie. Menton en latin s'appelle gonion. Donc, quand on dit latérogénie, c'est pour le gonion, c'est le terme en latin.

Mais en français, on dit latérogénie, rétrogénie. Les lésions des téguments. On peut trouver une échymose, un hématome, des plaies.

Donc, on l'a dit, une plaie du menton doit faire rechercher une fracture mandibulaire. Des hémorragies, soit cutanées, soit dans la cavité buccale, soit le conduit auditif. C'est l'examen maxillofacial.

La palpation doit être bilatérale et symétrique du bord basilaire et des bords postérieurs des branches montantes de la mandibule. Point douloureux exquis, décalage, déformation, mobilité anormale. C'est ce que cherche toute palpation sur l'os, même le fémur.

C'est un point douloureux, un décalage, une déformation, une mobilité. Pour ceux qui vont préparer l'internat après, quand vous préparez toutes les fractures, vous n'allez pas chaque fois changer de plan. A la palpation, il y a toujours point douloureux, décalage, déformation, mobilité.

Vous devez apprendre à apprendre les choses d'une manière structurée. La palpation bilatérale de l'articulation temporomandibulaire. Excusez-moi.

Je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que vous voulez vous reposer un peu ou bien je continue le cours jusqu'à un certain moment? Tout le monde est d'accord? Oui, dites oui. Oh là là là là.

Oui, lundi, vous êtes endormi après un week-end. Bon, donc voilà. La palpation bilatérale de l'articulation temporomandibulaire à la recherche de douleurs au conduit auditif externe, région pré-thravienne.

Donc, les douleurs, la mobilité des condyles et la vacuité pré-thravienne. Je m'explique. Pour examiner une articulation temporomandibulaire, il y a bien sûr l'inspection.

Si ce n'est pas vide au regard du conduit auditif. Sinon, la palpation. Deux temps.

Le premier temps, c'est devant le conduit. Si vous mettez les deux index devant le conduit, vous ouvrez fermé, qu'est-ce que vous sentez? Il y a une boule d'os qui bouge. C'est le conduit.

Quand il s'ouvre, il se luxe. Quand il se ferme, il se remet en place. Vous prenez l'index.

Mettez-le dans le conduit auditif. Vous ouvrez, vous fermez. Vous sentez que ça bouge.

Eh bien, s'il y a une fracture, on risque de créer la douleur déjà en palpant. Et on risque d'avoir l'absence de ces mouvements. Et voilà comment on fait.

Regardez. Donc, la palpation du rebord basilaire et du bord postérieur de la mandibule. Voilà.

Le conduit auditif et la région pré-thragienne. Et puis, on peut faire une pression latérale sur les deux joues. Et ça crée des douleurs là où il y a des fractures.

Nous avons une autre manœuvre. Ce sont les douleurs provoquées à distance. C'est à dire si vous appuyez sur le montant, vous provoquez des douleurs de l'articulation

temporomandibulaire.

Et vous appuyez sur les angles, vous créez des douleurs au niveau sympathique s'il y a une fracture. Et on finit cet examen par l'examen neurologique à la recherche d'une hypo ou d'une anesthésie labio-mentonnaire. Je rappelle au niveau de la mandibule, vous avez un nerf qui traverse.

Et s'il y a une fracture sur le trajet du nerf, il y a une compression et nous avons une anesthésie labio-mentonnaire. Est-ce que c'est clair? Dans la fracture du malheur, nous avons une anesthésie infrarorbitaire de la joue. Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez? Fracture du plancher de l'orbite, fracture de l'osigomatique.

Il y a un nerf qui sort ici. C'est le nerf infrarorbitaire. Il y a de l'anesthésie infrarorbitaire.

Au niveau de la mandibule, il y a le nerf mandibulaire qui traverse. Les fractures mandibulaires vont créer une anesthésie labio-mentonnaire. C'est un examen qui est médico-légal.

Et ensuite, on fait l'examen endobuccal. C'est un temps très important parce que nous avons la mandibule et porteuses de dents comme le maxillaire. Quand il y a une fracture dentaire, il y a une perturbation de l'alignement des dents inférieures par rapport au supérieur qu'on va supposer saine.

Ça veut dire que le maxillaire n'est pas fracturé. Et dès qu'il y a une interruption de l'arc mandibulaire, l'alignement est interrompu. Et quand l'alignement est interrompu, ça va perturber les rapports entre les dents du bas et les dents du haut.

Si on revient aux définitions, on oublie la plaque. Les dents du haut et les dents du bas, est-ce qu'elles sont articulées? Oui. Par la relation qu'on appelle articulée dentaire.

Articulée dentaire. Ça veut dire articulation entre les dents supérieures et les dents inférieures. Est-ce qu'on l'appelle en arabe? Oui.

Est-ce qu'on l'appelle un malade? Quand on a une fracture mandibulaire, on dit qu'il a frappé les dents du bas. On dit que non, docteur. Qui a frappé les dents? Je le redis.

Quand le patient a un traumatisme de la mandibule, quand on lui demande si les dents du haut et les dents du bas sont accrochées les unes aux autres, il vous dit non. Ça veut dire la manière de mordre. Alors ça, ça s'appelle l'articulée dentaire.

C'est quoi un articulée dentaire? On l'a vu en deuxième année. C'est l'expression de la relation entre les dents supérieures et les dents inférieures. C'est l'expression occlusale entre les dentures maxillaires et mandibulaires où elle est extrêmement précise.

Regardez ici. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez ce petit schéma? Les étudiants, vous

voyez? Donc, on voit que le milieu du haut s'accommode avec le milieu du bas. Il y a une relation particulière.

On va aller sur l'image qui est en bas. Regardez-moi cette image. Est-ce que vous la voyez? Alors, voilà le milieu du haut.

Voilà le milieu du bas. Est-ce qu'ils sont accordés? Il y a un décalage interincible. Regardez ici.

Il y a le milieu du haut qui est simple. Le milieu du bas, il est décalé. Cet espace s'appelle la béance.

Béance, quelque chose de béant, ouvert. Donc, c'est une béance. Donc, nous, parmi les éléments qu'on cherche, c'est cette perturbation de l'articulé dentaire qui traduit tout simplement que l'arc mandibulaire est cassé.

Il est interrompu. Et en fonction du siège de la fracture, il va donner un type d'articulé perturbé. Donc, je reviens pour dire que l'examen endobucal dans la bouche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les dents maxillaires et mandibulaires.

On parle mandibule. Donc, il y a les dents qui portent la mandibule cassée. Il y a de la gencive.

Il y a de la langue. Et il y a de la dynamique et de la fonction. La fonction, c'est l'articulé dentaire et l'ouverture buccale.

L'articulé dentaire, c'est la fermeture. Et l'ouverture, c'est une fonction. C'est une fonction très importante parce qu'on ne peut pas manger sans la mandibule.

Vous le savez, ça. Est-ce que vous savez ça? Sans la mandibule, on ne peut pas manger. C'est la mandibule qui est osmobile et qui bouge.

Quand elle bouge, vous pouvez mordre la nourriture. Et vous pouvez mâcher. C'est grâce à la mandibule qu'on mâche, la mastication.

D'accord? Donc, nous, à l'examen clinique, on va vérifier tous ces éléments. Donc, quand vous allez ouvrir la bouche du patient et que vous allez regarder à l'intérieur, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche cinq éléments. La première des choses, c'est le degré d'ouverture buccale.

Parce qu'on sait qu'il est fracturé, que la mandibule permet l'ouverture. Normalement, c'est impossible d'avoir une fracture. C'est exactement si quelqu'un a une fracture de la jambe.

La marche, c'est les membres. Et l'ouverture, c'est la mandibule. Donc, normalement, ce qu'on appelle une limitation de l'ouverture buccale.

Toute limitation de l'ouverture buccale en traumatologie au HORT est anormale. Elle doit être expliquée. Deuxième chose, l'articulé dentaire.

Donc, on va lui demander d'ouvrir et de fermer. Et quand il ferme, qu'est-ce qu'on cherche? C'est cette relation entre les dents supérieures et les dents inférieures. Donc, comme il est fracturé, on s'attend à ce que ça ne soit pas parfait.

Donc, ça peut être une béance, une latérale déviation, un diastème, une déviation interincisive, etc. Mais on cherche aussi des lésions muqueuses, des plaies, de l'agencement, de la langue du plancher buccal. Mais on cherche aussi le buccal hématome, ça veut dire un hématome du plancher buccal, qui peut tuer un patient.

Une fracture bifocale, biangulaire ou biorizontale de la mandibule, qui s'allait beaucoup, le saignement se fait vers le plancher buccal, vers la langue, ça peut tuer. Parce que l'hématome va tuer sur la langue, vers les voies aérodynamiques supérieures. Et le patient peut s'affixer.

Quatrième chose qu'on cherche, c'est les dents. Parce que si c'est un enfant, ou un chien, il est en forme de mixte permanente. Est-ce qu'il y a une mobilité d'une dent? Est-ce qu'il y a une? L'état des dents qui sont situées dans la fracture a la ressource d'une carie, parce que non seulement les fractures, elles sont pourvoyeuses d'infection, mais s'il y a une carie dentaire, il y a un facteur supplémentaire de l'infection parce que la carie dentaire, c'est une écrosse, c'est un foyer qui tue l'une des microbes.

Donc, ça, c'est l'examen endobutale. Voilà l'articulé dentaire sur ce schéma. Voilà un articulé parfait ici, regardez-moi, les dents qui se regardent du haut vers le bas, et voilà des articulés perturbés.

Alors, regardez-moi ça, c'est quoi ça? On commence par ça, c'est quoi ça? C'est une béance, béance, béance, vous avez vu? Une béance, maquillage, et là, il y a un décalage ici et il y a une béance, regardez-moi ça, c'est une béance. Là, il y a ce qu'on appelle un diastème, un espace interdentaire. Là, il y a un décalage inter-incisif supérieur et inférieur.

Ça crée ce qu'on appelle un articulé croisé. Bref, même si vous ne décrivez pas les signes devant ces perturbations, mais quand vous ouvrez la bouche ou vous trouvez des choses anormales comme ça, ça veut dire qu'il y a des fractures. Ça veut dire que la mandibule a été cassée, qu'elle n'est plus en alignement, c'est qu'il faut faire une radio pour vérifier la fracture.

Donc, cette radio, c'est l'imagerie, bien sûr, c'est la radio panoramique ou orthopantomographe. Excusez-moi, je vais changer panoramique. Parce qu'on dit panoramique, on dit orthopantomographe.

Voilà donc, si je vous pose la question, quelle est l'exploration est-il dans les fractures mandibulaires? Est-ce que c'est le scanner comme le massif facial? Non. C'est la radio. Panoramique, ce qu'on appelle dans le grand bien l'orthopantomographe.

Nous, voilà, c'est ça, l'orthopantomographe, c'est ce que vous voyez ici. Mais on demande le

scanner quand il y a une contre indication à l'orthopantomographe d'une part et s'il y a des lésions associées. Or, pensez que quand il y a une fracture isolée et que le maxillaire et le malaire et le front est parfaitement normal à l'examiner, qu'on fait un orthopantomographe.

On ne sait pas systématiquement où c'est. On a des scanners, mais on n'a pas d'orthopantomographe. On les envoie dans le privé pour le faire.

Donc, on est plus scanner orthopantomographe et chez l'enfant. Bien sûr, on fait un scanner parce que l'enfant s'agit parce que pour faire l'orthopantomographe, on doit être assis. Quelqu'un qui a une fracture du fémur ne peut pas le faire.

Quelqu'un qui a une fracture de la colonne ne peut pas le faire. Quelqu'un qui est en coma ne peut pas le faire. Donc, nous, on dit c'est l'orthopantomogramme en dehors des contre indications.

Si je vous pose un QCM, un patient de 15 ans ou de 25 ans vous consulte pour une douleur de l'ATM, une douleur parasymphysaire suite à une chute de sa hauteur. Quelle diagnostic vous évoquez? Douleur parasymphysaire, douleur candylienne, suspicion de fracture candylienne, suspicion de fracture parasymphysaire. Quel est l'examen paraclinique utile? Vous allez me répondre scanner ou bien orthopantomographe? Orthopantomographe, voilà, qu'est ce que vous voyez sur cet orthopantomographe? Qu'est ce qu'il y a ici? Qu'est ce qu'on voit ici? Qu'est ce que vous voyez? Les amis de l'Internet ne répondent pas.

Vous, qu'est ce que vous voyez? C'est quoi ça? Est ce que vous voyez quelque chose ici? Là, c'est une fracture de la branche. Horizontale et là, on m'a répondu parasymphysaire, non, c'est une branche horizontale. Pour parler de parasymphysaire, on doit être entre la canine et la centre.

La région symphysaire, c'est ici. Ici, c'est une branche horizontale, c'est entre la canine et la molaire. Ici, pareil, entre la molaire et la canine, c'est une branche horizontale assez fastidieuse.

Alors ici, c'est une autre incidence face basse. Regardez, qu'est ce que vous voyez ici? Fractures condyliennes avec luxations. Là, c'est un scanner.

Qu'est ce que vous voyez? C'est des fractures de la région symphysaire. Et là, qu'est ce que vous voyez sur ce scanner? On va voir ici. Qu'est ce qu'on voit sur le scanner? Une fracture de la branche horizontale et une fracture de l'angle mandibulaire.

Voilà, je crois qu'on a fait le tour des choses. Donc, l'imagerie, elle est utile parce qu'elle permet de confirmer le diagnostic clinique. Ça, d'une part.

De voir le trait de fracture, le nombre, le cercle et la direction. L'état des dents, les fractures pathologiques et les lésions associées, c'est un peu l'utilité. Et là, on va passer aux formes cliniques.

C'est important parce que vous risquez d'avoir des questions sur les formes cliniques. Donc, si on revient à la classification qu'on a vu tout à l'heure, on va y revenir très vite. Vous vous rappelez de la classification au début, on l'a vu.

Alors, elle est là, la classification. Vous avez vu? Fracture symphysiaire, fracture paraphysiaire, branche horizontale, fracture de l'angle, fracture de la branche montante, fracture du coroné et fracture pandylienne. Est ce que vous avez vu ça? En fait, Jewel a parlé de fracture Mornington, de fractures de l'angle ahurie.

Aujourd'hui, on a aussi une visits chandelle, on a aussi un losers candle dot pasteur. Et c'est recentré sur notre secteur hospitalier. Donc, finalement ce que vous trouverez c'est la branche montante qui appartenait parfaitement aussi au appartient à la portion dentelle.

L'onguille, il appartient aux deux en fait, mais on va le garder dans la branche mentale. La branche horizontale, la voilà. Elle est entre la molaire et la canine.

Elle appartient à la portion dentelle? Oui. Les fractures paracentés, c'est-à-dire centrisères droite et gauche. Est-ce qu'elle appartient à la branche dentelle? Oui.

Très bien. Cette appartenance est très importante pour nous en tant que cliniciens. On va revenir à la dernière question.

La portion dentelle porte des dents. Qu'est-ce que c'est qu'elle? Que sont des fractures? Oui, il y a des fractures. Pourquoi? À cause de mort.

Des dents. Et les dents, quand il y a des fractures, elles se continuent avec la dent, la dent, les dents, la biche continue là. Et parce que l'onguille est collée intimement à la gouttule, et donc quand il y a des fractures, il y a des fractures de la gouttule.

Et même s'il n'y a pas de fractures, il y a des dents. Quand ça bouge, on le voit, on voit que ça bouge et ça calme. Donc, toutes les fractures de la portion dentelle dans les fractures ouverts.

Et si ce sont des fractures ouverts, à l'arrivée d'un jour ou d'un autre, il y a des fractures de dents, des dents, des dents qui gâchent. Des soins de goutte, bronchage. Les fractures de la branche montante sont ouvertes.

Est-ce qu'elles sont ouvertes? Est-ce qu'elles sont cachées? Est-ce qu'elles sont maquillées par un médecin maquillateur? Oui, elles sont trop fortes. Est-ce qu'elles sont en relation avec les dents? Non, elles ne sont pas ouvertes, sauf dans les fractures. Donc, ce sont des fractures.

Est-ce qu'on va donner des antibiotiques? Il n'y a pas de raison. Elles ont un signe commun, elles se ressemblent toutes. On va réfléchir un peu.

Les fractures de la branche montante, elles sont en relation avec les muscles masticateurs. Ce sont les muscles qui vont laisser l'ouverture et la fermeture. S'il y a une fracture, le muscle, il réagit par une contracture et donc il crée une limitation de l'ouverture des cages.

Toutes les fractures de la branche montante, y compris l'ongle, créent une limitation de l'ouverture des cages. C'est le dénominateur qu'on a. Pourquoi je vous casse les pieds avec ça? Bien, quand vous êtes dans vos cabinets et que vous recevez un patient qui n'a presque rien et qui vous dit docteur, je ne sais pas, je me suis réveillé aujourd'hui et je n'ouvre plus la bouche. Il y a d'autres raisons de limitation de l'ouverture des cages, mais je vais éliminer la cause traumatique.

Rael Mredi ne vous a rien dit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas complété l'information. C'est à vous de poser la question. Qu'est-ce que vous allez lui poser comme question? Est-ce que vous avez reçu un traumatisme? Chut, il n'y a pas que la chute, il y a la gifle.

Il y a la porte qui revient sur la bouche. Il y a la chute, il y a l'agression. Les gens ne disent pas tout.

Des fois, la fille ou la dame vient avec le mari, elle vous dit je suis tombée dans les escaliers, elle a reçu une gifle, elle a été tabassée. On s'en fout, nous, la cause, mais il y a traumatisme. Parce que s'il n'y a pas de traumatisme, on va penser au tétanos, on va penser à la cellulite, aux causes infectieuses.

Mais nous, il n'y a rien, il n'y a ni fièvre, ni rien du tout. Mais c'est un patient, il a un tout petit peu la joue gonflée et il n'ouvre pas. C'est une fracture de l'ongle par un choc direct.

Tout à l'heure, on a dit, vérifiant, est-ce que c'est un choc sur le menton ou sur l'ongle? Et des fois, les adultes ne disent pas tout. Donc, nous, en tant que médecin, on a besoin d'un médecin pour qu'on le comprenne et pour que vous puissiez le traiter. Est-ce que c'est clair? Donc, toute limitation de l'ouverture buccale post-traumatique est une fracture, jusqu'à preuve du contraire.

Faites la radio et l'imaginez. Donc, toutes les fractures rétrodentées, ongles, branches mentales, coronées et candyless sont des fractures convoyées de l'imitation de l'ouverture buccale. Alors que les fractures de la portion dentée, elles sont ouvertes.

Elles perturbent l'articulé, mais elles ne rotentissent peu sur l'ouverture buccale. Alors, on va voir les formes cliniques. Je vois qu'il est trois heures.

On va continuer. Alors, quelles sont les formes cliniques? Donc, on a dit les formes cliniques, ça va être les rétrodentées et les... On va voir, on va coller qu'est-ce qu'il y a. Professeur, on ne vous entend pas. Et maintenant, vous m'entendez? Oui, très bien.

Je reviens au micro. Vous avez raison, il faut que je sois disciplinée. Bien, donc, les formes

cliniques, nous avons les fractures de la partie dentée.

Là, voilà la partie dentée. C'est celle qui porte les dents. Le siège, il peut être symphysaire, branche horizontale ou longue.

Les particularités, c'est qu'elles déforment l'arcade dentaire. Elles sont toujours des fractures ouvertes en raison de l'adhérence étroite de la fibre omiqueuse, gingivale à l'os, faisant communiquer le foyer fracturaire avec la flore bactérienne du milieu buccal. Elles exposent aux risques infectieux et elles exposent aux risques respiratoires, surtout quand elles sont bilatérales à cause de la glosso-optose qu'elles peuvent induire.

Est-ce que c'est clair? Elles déforment l'arcade dentaire. Elles sont toutes ouvertes. Donc, elles exposent aux risques infectieux.

La clinique commune, les formes de la partie dentée, douleur au foyer, quand on va palper le foyer, il y a une douleur sur place et les troubles de l'articulé dentaire, les décalages interincisifs ou à décalage, une béance latérale, un diastème, c'est un espace entre les dents, etc. Alors, les voilà, ces fractures. Nous avons les fractures symphysaires.

Elles sont entre les deux canines. Les voilà, entre les deux canines. Nous avons les médiums, celles qui peuvent être au milieu, et nous avons le parasymphysaire droit ou le parasymphysaire gauche.

Est-ce que cette fracture est médiane? Je reviens ici. Là, est-ce qu'elle est médiane, cette fracture? Oui, elle est médiane, elle est au milieu. Est-ce que cette fracture est médiane? Est-ce que cette fracture est médiane? Elle est parasymphysaire, parasymphysaire droite.

C'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc, les fractures symphysaires de la région symphysaire, qu'elles soient médianes ou bien paramédianes, elles vont entraîner un trouble de l'articulé, mais il n'y a pas d'hypoesthésie labiomentonnière. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que le nerf s'arrête avant la fracture. Tout simplement, l'émergence du nerf, la sortie du nerf, c'est à côté de la première prémolaire.

Et donc, on est à côté de la canine, il n'y a pas de nerf, donc il n'y a pas d'anesthésie. Fracture de la branche horizontale. Voilà la branche horizontale.

La voilà ici, en dehors de la canine, c'est une branche horizontale. Elle donne le même tableau clinique, mais il y a une hypoesthésie labiomentonnière. Pourquoi, par définition, dans la branche horizontale, passe le nerf, que ce soit à côté de la première prémolaire ou dans la dent de sagesse, c'est la même chose.

Sur toute la portion, il y a du nerf, et là que ça fracture, ça entraîne une hypoesthésie labiomentonnière. Est-ce que c'est clair? Fracture de l'ongle. La fracture de l'ongle, on peut la mettre dans la branche montante ou dans la partie dentée.

Or, cette fracture de l'ongle, ça fait les signes, les fractures de l'ongle, ça fait les signes de la branche horizontale. C'est une fracture ouverte, comme la branche horizontale, mais aussi, elle entraîne une limitation de l'ouverture buccale. Elle a les deux caractéristiques parce qu'elle est dans une zone transitionnelle.

Donc, vous avez l'hypoesthésie labiomentonnière et la limitation de l'ouverture buccale. Donc, si on résume les fractures, on vient de l'angle, il y a la fracture de l'angle, la fracture de la branche horizontale et la fracture symphysaire, parasymphysaire droite et gauche. Or, elles donnent toutes troubles de l'articulé, troubles de l'articulé, troubles de l'articulé.

La première, pas d'hypoesthésie, la symphysaire, les deux autres, hypoesthésie labiomentonnière et la fracture de l'angle va donner une limitation de l'ouverture buccale. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est la portion dentée.

Alors, la demoiselle qui met le bleu, là, vous vous appelez comment? Nisrine. Le docteur Nisrine de garde chez Mercedes. Je l'ai appelée au déchocage.

Parce que l'internat, il dit qu'il est obligé de se plier et le pauvre, il ne dit pas non. Mais au fond, quand on l'envoie, c'est pour son intérêt, pour apprendre. Mais bon.

Docteur Nisrine, chez le déchocage, elle est venue, elle a trouvé un polytraumatisé qui est conscient. Fractures costales, fractures du fémur. Mais il n'est pas intubé, il est conscient.

Et elle a trouvé que sa face est enflée. Donc, tu me fais côté droit, là, côté droit vers l'angle mandibulaire et vers la mandibule. Elle l'a interrogée parce qu'elle est consciente et lui a dit j'ai chuté de ma moto.

J'ai glissé, je ne mettais pas de casque et j'ai glissé et voilà ce qui m'est arrivé. Elle va lui poser des questions, les signes fonctionnels. Est-ce que vous avez mal? Il lui a dit oui, docteur, j'ai mal ici.

Est-ce que vous arrivez à ouvrir la bouche? Non, je n'arrive pas, il a du mal à parler, il n'arrive pas à ouvrir la bouche. Je n'arrive pas, j'ai du mal à avaler. Elle lui a donné, est-ce que vous avez des troubles de la déglutition? Est-ce que vous avez toutes les questions? Elle a demandé qu'on lui donne des gants.

Elle a pris des ébaisses-langues, elle a regardé en endobuccal et elle a trouvé qu'il y a une béance latérale et qu'il y a un trouble de l'articulé dentaire et que le patient n'arrive pas à ouvrir la bouche. Il a pris des gants, elle a palpé le rebord basilaire et elle a trouvé qu'il y a une douleur au niveau de l'angle mandibulaire strict. Même si le patient dit tout ce côté me fait mal, elle a pris l'index, elle a suivi le rebord basilaire, le rebord, le rebord jusqu'à l'angle.

Là, il a hurlé, il a dit aïe, j'ai mal. Elle a été, elle voulait demander un scanner. Elle ne peut pas, il

a une fracture de la jambe, un orthopentomogramme.

Elle ne pouvait, elle s'est rappelée que l'orthopentomogramme, il faut qu'il soit assis. Elle a demandé un scanner, le réanimateur lui dit, il a un scanner. Elle a regardé le scanner, qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Une fracture de l'angle.

Donc, quand elle a trouvé cette fracture de l'angle, elle s'est rappelée de son cours. Quelle est l'ordonnance que tu vas prescrire et qu'est-ce que tu vas dire à ce patient ? Qu'est-ce que tu te rappelles de ce que je viens de dire ? Fracture de l'angle, est-ce que c'est une fracture ouverte ou fermée ? Ouverte, donc tu dois donner des antibiotiques. C'est une fracture qui limite l'ouverture buccale.

Donc, tu vas donner un peu d'antalgique et mieux relaxant pour relâcher. Qu'est-ce que tu vas conseiller au patient ? De se laver avec un antiseptique ou bien avec de la bétadine diluée, la cavité buccale. Mais tu n'as pas oublié les antibiotiques, c'est une fracture ouverte.

Mais, docteur, c'est l'élément important dans l'examen clinique. Toi qui fais les gardes au maximum. L'anesthésie, la biomontage.

Parce que c'est médico-légal, c'est un accident de la République. Ce monsieur-là sera opéré, réparé, tout ira bien. Mais ce qu'il risque de garder, c'est l'anesthésie, qui est très gênante dans la vie quotidienne.

Elle nous sert à quoi, l'anesthésie, la sensibilité ? Excusez-moi, mes yeux me brûlent. Elle sert à quoi dans la vie, la sensibilité ? Quel est le rôle de la sensibilité ? Qu'est-ce que c'est utile pour nous de sentir une main ? Éviter les brûlures, ça veut dire la protection. Ça veut dire sentir le danger.

Et quand on sent le danger, on fait ça. Vous vous rapprochez, vous trouvez que c'est... Vous vous éloignez. Un corps étranger se rapproche, les yeux, on ferme.

La sensibilité de la conjonctive. Vous avez compris ? Donc, la sensibilité nous protège. Quelqu'un qui a une anesthésie complète de la lèvre inférieure droite, s'il est fumeur, qu'est-ce qui risque de se passer ? Pas que de brûler, de cramer sa lèvre sans se rendre compte.

Elle peut brûler jusqu'à la brûlure complète, mais elle ne le sent pas. Deuxième chose, quand il mange, quand on mange, pas que sa lèvre, je parle de la lèvre. Il ne sent pas la chaleur des aliments et les mouvements aussi.

Ça perturbe l'appréhension de la lèvre. Donc, cette sensibilité est utile. Quand quelqu'un a une anesthésie, il a des problèmes.

Donc, nous, nous devons noter. Donc, docteur, cette maquette-bêche m'a une anesthésie la vieux-ventomière. Donc là, c'est les fractures de la portion dentaire.

Nous allons voir les fractures de la portion rétro-dentaire. Enfin, une chose. Les fractures de la portion non dentaire.

Alors, le siège, c'est en arrière de l'arcade dentaire. C'est la branche montante, c'est les condyles et le corone. Les particularités, c'est qu'elle déplace toute l'arcade dentaire en totalité.

C'est ce que je disais à la fracture. Ça tire toute l'arcade entière. Et surtout, il y a un risque d'onkylose temporomandibulaire.

La douleur, elle est au foyer, provoquée à distance. Il y a une limitation de l'ouverture buccale. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a une limitation de l'ouverture buccale.

Voilà, vous avez vu ? On peut avoir une latérodéviation de l'arcade, donc l'arcade qui sous-dévie. Regardez la latérodéviation, vous avez vu ? Elle sous-dévie l'arcade complètement. Et on peut avoir un trouble de l'articulatif décalage intéracidif, comme cela.

On peut avoir un contact molaire prématuré. Vous avez vu le contact molaire prématuré ? Normalement, quand vous fermez, vous pouvez les voir. Les molaires en arrière, c'est ça ? Et les molaires qui sont plus vite, ils sont plus près en haut.

Quand il y a une fracture d'un côté, c'est du préau. Lors de la branche de l'enchant, il y a un rapide déplacement du côté de la fracture. Et donc, il n'y a pas de molaire.

C'est que c'est plus vite que l'instant, et le molaire est plus près. C'est juste cela. Alors, les fractures, elles sont nombreuses.

C'est ça la béance. Donc, on a les fractures condyliennes. C'est la tête et le col.

Le mécanisme, c'est un choc direct. Et on a les fractures articulaires et extra-articulaires. Et les voilà, ces fractures.

Vous avez vu sur le schéma ? Voilà, c'est ça les fractures condyliennes. C'est les condyles qui se détachent et se distordent et se mettent en ondulation. Donc, vous imaginez qu'il y a des douleurs rétragènes à la palpation.

Si les condyles se luxent, ouvrez fermement. Vous sentez la petite boule. Si le condyle est luxé à l'intérieur, est-ce que vous allez sentir la boule ? Il y a une vacuité de la glaive, une vacuité de la partie préauriculaire.

C'est vide. La vacuité, ça veut dire que c'est vide. Donc, absence de mobilité condylienne.

On peut avoir une autoragie. Pourquoi on peut avoir une autoragie ? Quand le condyle se luxe, qu'est-ce qu'il fait ? Il déchire le conduit auditif externe en arrière et il fait c'est vide. La limitation de l'ouverture de caille, la latérode de déviation et l'abéance contre l'abéance.

Quel est le risque de ces fractures ? C'est l'ankylose temporomandibulaire chez l'adulte et en plus chez l'enfant, la dysmorphie faciale avec troubles de la croissance chez l'enfant. Donc, ce sont des fractures qui peuvent être graves, non seulement par les risques fonctionnels qu'elles induisent, mais les troubles de la croissance qu'elles peuvent créer chez la personne si elles ne sont pas très bien traitées. C'est pour cela que tout choc sur le menton doit faire rechercher les fractures pendulières.

Toute plaie sur le menton doit faire rechercher les fractures pendulières. Si le patient ou la patiente vous dit, écoutez, on est alarmé, elle a été agressée dans la rue par un homme et lui a donné un choc sur le menton, je vais vérifier mes fractures pendulières. La patiente vous dit, non, non, non, docteur, si ici j'ai été choqué, je lui dis, c'est clair, laissez-moi faire mon travail, je sais clair, ne nous montrez pas ce que vous voulez.

Et si vous êtes gentil, vous lui expliquez, vous lui dites s'il y a des risques. Mais moi, je n'explique pas parce que je vais alarmer la patiente. Je préfère ne pas alarmer les gens et dire, écoutez, laissez-moi faire mon travail, je finis et je vous explique.

Donc, vous voyez ici qu'il y a une fracture symphysaire et qu'il y a du condylien. C'est un classique. Un choc, un coup de poing sur le menton fracture la symphyse, mais fracture aussi par choc indirect, par mécanisme indirect, les deux condyliens.

Les fractures de la branche mentante, pareil, limitation de l'ouverture buccale. Les fractures du coronet, pareil, limitation de l'ouverture buccale. Et il y a toujours un risque d'un condylien.

Les fractures associées existent. Donc, vous voyez ici qu'il y a plusieurs fractures associées à des fractures du massif facial. Donc là, il y a un le for 1, il y a un le for même 2 d'un côté.

Donc, il y a un fracas facial, ça existe. Les fractures de l'enfant, donc en fonction du terrain. On vient de le dire, les enfants, voilà, regardez sur le scanner.

C'est quoi ça? C'est une fracture sous-condylienne. Et là, c'est une fracture luxation, fracture luxation. Le condyle s'est fracturé, mais il s'est luxé en dedans.

Donc ça, c'est le scanner. On a dit que chez l'enfant, on a du mal à voir le condyle. On fait des scanners.

Donc, il y a un choc sur le mentant. Il y a une fracture du condyle par l'examen et l'imagerie. Et ça pose problème.

Quels sont les risques des fractures chez l'enfant? C'est l'ankylose temporomandibulaire. C'est la dysmorphose mandibulofaciale. Et c'est la fragilité accrue par les dents mixtes.

Ça veut dire quoi? C'est que chez l'enfant, quand il est fracturé, même d'une branche horizontale, il y a des dents qui ne sont pas encore sorties à l'extérieur, qui sont dans l'os. Il n'a que des dents

de lait et les autres dents sont là. Et donc, on perturbe même la croissance des dents.

C'est pour cela que c'est des formes assez particulières. Les fractures de la dentée. Donc, on a aussi des patients qui peuvent ne pas avoir de dents.

Si les sujets âgés souvent pas les dentations, on va être responsable d'une résorption de l'os alvéolaire. On sait que l'os alvéolaire qui porte les dents, il naît et il meurt avec les dents toujours. Et donc, le denté n'a pas de dents, n'a pas d'os alvéolaire.

Donc, il y a un manque de hauteur. Il y a des problèmes. Et donc, la fracture rotante est non négligeable sur l'état général.

Le risque de pseudarthrose et ça pose pour nous en tant que maximum des problèmes de traitement parce que nous, pour traiter une fracture, on se réfère à l'articulé dentaire et aux dents. Et on trouve les solutions bien évidentes. Les formes compliquées.

Donc, c'est les formes qui vont créer des complications. On peut avoir un polytraumatisme et un état de choc. Donc, le saignement, l'asphyxie.

Alors, quelles sont les fractures qui peuvent créer une asphyxie? Je vais revenir ici. Est-ce que les fractures bilatérales de la branche horizontale peuvent entraîner un hématome du plancher? Oui. Plancher buccal.

Est-ce que les fractures biangulaires, les deux angles, risquent de créer un hématome du plancher? Oui. Est-ce que les fractures parasymphysaires bilatérales risquent de créer un hématome du plancher? Oui. Et tout cela peut entraîner une glossoptose aussi, parce que les attaches des muscles de la base de la langue sont accrochées sur la mandibule.

Et si l'arc mandibulaire a éclaté des deux côtés, là et là, la langue va se sauver en arrière. C'est mécanique. Et donc, il y a un risque d'asphyxie.

Si on dit la question « Quel est le risque d'une fracture mandibulaire ? » Il y a un risque fonctionnel d'une fracture mandibulaire qui est le risque de l'asphyxie. On l'oublie. Est-ce qu'il y a un risque de l'asphyxie? Oui.

C'est l'asphyxie. Soit par une fracture bilatérale glossoptose, soit par un hématome du plancher buccal. C'est pour cela que quand vous examinez l'examen endogypaste, vous allez surprendre l'hématome sous la langue pour qu'il ne grandisse pas, qu'il ne crée pas d'asphyxie chez le patient.

Donc, les formes graves, compliquées, nous avons celles du polytraumatisme, mais nous avons aussi les complications. Nous avons l'état de choc, l'asphyxie et l'hémorragie faciale. Les complications secondaires, nous avons les infectieuses.

Ces fractures peuvent entraîner des cellulites, des ostéites qui vont nécessiter une prévention par les antibiotiques. On l'a dit, que toutes les fractures de l'arc denté nécessitent une antibiothérapie. Ce sont des fractures ouvertes.

Est-ce que c'est clair? Toutes les fractures de la portion dentée où il y a des dents sont des fractures ouvertes. Si on ne donne pas d'antibiotiques, quel est le risque? Une cellulite. Et la cellulite, c'est de vous écouter, mademoiselle, elle est grave.

Vous avez compris ça. C'est une infection qui peut tuer. On peut avoir, comme toutes les autres fractures, un retard de consolidation et une pseudarthrose.

Alors, est-ce que vous avez retenu avant que je ne passe au traitement? Donc, nous avons les formes cliniques. D'abord, l'examen clinique, l'inspection, l'articulation de conscience, la palpation, une douleur expirée, l'examen de l'articulation temporomandibulaire et l'examen endovital. Alors, on cherche, dans le trouble de l'articulé, l'imitation.

Quand vous regardez le fait, on va simuler l'examen clinique. Vous avez, et par contre, vous allez lui demander d'ouvrir. Toutes les moitiés.

Vous allez dire, là, bien sûr. Et là, bien sûr. Donc, vous allez noter, l'imitation de l'examen clinique.

Toutes les moitiés. Vous trouvez que les dents ne changeraient pas correctement. Trouble de l'articulé d'enfance.

Vous regardez, les jeunes, il y a une flemme sur la dentiste en regard du faillite. Vous allez lui dire, il y a un élément d'impotence. Vous allez regarder les dents.

Est-ce qu'il y a plus les dents ? Est-ce qu'il y a une partition ? Est-ce qu'il y a de la farine ? Et puis, vers la fin, vous allez vérifier la structure. Avec ça, vous pouvez trouver une fracture avec l'examen clinique. Si la douleur au paracatéle Et si, à l'intérieur, vous pouvez discuter en regard de la fracture.

Et puis, si c'est bien, la fracture sera difficile. Si vous avez une douleur au niveau de l'endroit et que le patient n'arrive pas à ouvrir la bouche, l'imitation de l'exercice, et que la fracture de l'endroit ne fait plus l'endroit. Si le patient a une douleur préauriculaire et qu'il n'arrive pas à ouvrir la bouche, rappelez-vous que les fractures de la branche mentale sont courvoyantes de l'imitation de l'ouverture buccale.

Et que toute l'imitation de l'ouverture buccale post-traumatique est une fracture de cette structure. Donc, je suspecte une fracture fondamentale, l'angle mandibulaire, la branche mentale, et le coroneau. Mais, je ne suis pas sorcier.

Il faut une radio. Quelle est l'exploration sur ce patient qui est conscient, qui marche, qui est bien

portant, qui est adulte ? Qu'est-ce que vous allez lui demander ? Porte pantomime ! C'est parfait. On arrive.

Quelles sont les renseignements que vous cherchez sur ce patient qui est malade ? 1. C'est simple. Il faut qu'il pense à lui-même. 2. N'étonnez pas.

Est-ce qu'il y a... J'analyse le trait. Est-ce qu'il est oblique ou est-ce qu'il y a des fractures qu'on ne voit pas ? Donc, je fais l'examen complet de la mandibule. Et vers la fin, il y a une autre fracture qu'on cherche sur le radio.

C'est quand il y a des fractures de la mandibule. Des fois, c'est comme ça que je demande à quelqu'un. Parce que si vous dites qu'il y a des fractures, je la vois, je mobilise la mandibule, ça bouge.

Si vous dites qu'il y a des fractures, je la vois, je mobilise la mandibule, Il y a des fractures de la mandibule. Il peut être à la réunion aussi. Bien sûr.

Un gros test de la mandibule est une fragilité. à l'occasion d'un mouvement violent ou d'une menace typique. Une fragilité forte, ça risque de frapper.

Alors, comment on traite ces fractures ? Quand toutes les frappes comptent, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, on n'a pas à faire. Ça va aller à l'hôpital. Deux membres comme je fais.

Une frappe compte. Quel est le principe du traitement des fractures ? Comment on traite les fractures ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, notre collègue vous a dit qu'il n'y a pas qu'un traitement chirurgical. Je suis désolée.

J'ai toute la gamme des fractures. Je vais soulager le patient. Et elle vous dit si c'est une fracture de la portion dentée, tu donnes antibiotiques, soins de bouche.

Et comme c'est une fracture aussi associée à la dentée, je vais donner un myorérelaxant et un antalgique pour relâcher la bouche du patient. Du brossage dentaire, M91. Ensuite, tu l'as adressé au maxilo.

Qu'est-ce qu'il doit faire dans l'absolu comme toute fracture ? Admettons, c'est pas un traitement d'évaluation. Tu as déjà évalué par l'examiner. Réduction.

Réduction. Le principe du traitement de toutes les fractures, c'est réduction, contention. Réduction, contention.

Réduction, contention. Je vais vous donner des exemples. Une fracture de tibia.

Je fais réduction, contention. Une fracture de l'humérale. La contention, elle peut être orthopédique, elle peut être chirurgicale, intrapocale, avec des plaques d'os synthèse, avec un clou, avec du fil d'acier, peu importe.

Ça veut dire qu'on va ouvrir et aller aligner l'os. Mais on peut réduire et mettre une plaque sur une jambe. Vous êtes d'accord ? Mais on peut aussi réduire et aller au bloc, ouvrir et mettre une plaque pour la contention.

Vous comprenez ce que c'est contention ? C'est comme contenir. Quand on a une fracture, on peut mettre une plaque sur la jambe. Alors, sur une mandibule, comment on va faire ? Est-ce qu'on va mettre du plaque ? Non.

Et on fait la réduction ? Oui. Et la contention, on peut faire soit ce qu'on appelle, on va le voir après, une contention bimaxillaire, qui est où le maxillaire joue le rôle d'une attelle et où on fait la mandibule. C'est le blocage du maxillaire au mandibule.

Parce qu'une jambe, on lui met du plaque. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait.

Oui, c'est avec la fracture. Qu'est-ce qui mobilise la fracture ici ? La mastication. Donc, on va l'empêcher de manger et on va bloquer la mandibule au maxillaire.

Mais si ce n'est pas suffisant et on a affaire à une fracture instable, on va ouvrir en bouche, décoller et mettre une plaque d'ostéosynthèse. Et en post-opératoire, quelle est l'ordonnance que vous devez préoccuper puisque j'ai ouvert ? Les antibiotiques, les corticoïdes, les antalgiques et les soins de bouche. Parce que nous avons affaire à des dents qui sont sales et qui risquent d'entraîner une infection.

On va regarder ce traitement de près. Donc, le but, c'est de rétablir à la fois l'anatomie des structures osseuses, l'occlusion dentaire et les fonctions de la mastication. Les moyens, vous l'avez dit, la prévention de l'infection, les antalgiques, les traitements squelettiques, ça peut être la rééducation.

C'est le régime liquide d'abord parce qu'on n'a pas le droit de mâcher, mais on ne peut pas aussi manger. La rééducation passive. Orthopédique, c'est le blocage maxillomandibulaire.

C'est l'équivalent du plâtre et du natel. Chirurgical, le plus souvent associé au blocage, c'est un abord direct du foyer par voie endobuccale, réduction et contrôle de la vue osseosynthésophile d'acier ou bien plaque visée ou un fixateur externe. Regardez-moi le traitement orthopédique.

C'est le blocage maxillomandibulaire pendant quatre à six semaines de deux arcades. Les voilà. Voilà le blocage par les arcs ici.

On peut faire un autre type de blocage sur les vis. Et puis chirurgical, c'est l'osseosynthèse. Regardez-moi ça, la plaque.

Et voilà, sur la radio, on voit ici deux plaques avec le blocage. Les indications pour les fractures stables et unifocales, c'est un traitement orthopédique et fonctionnel. Ça veut dire blocage

intermaxillaire et alimentation liquide.

Et pour les fractures instables, plurifocales, on va faire de la chirurgie orthopédique. Est-ce que vous avez des questions à poser? Les étudiants. Je vais voir vos confrères.

Est-ce que vous avez des questions à poser, les étudiants? Oui? Oui? Pardon, est-ce que en chromato... Le dentif... Non, s'il vous plaît. Non. C'est pas, en vrai, c'est pas de la même manière qu'en chromatologie pour la demande du radio.

Pas toutes plaies qui nécessitent une fracture. Nous, nous avons les plaies par arme blanche. Elles le fracturent.

On va pas demander la radio. C'est une bonne partie. Lui, il fait la garde.

Allez, allons. Les plaies, il y en a beaucoup en maxilloire. Il y a beaucoup d'agressions.

Et ces plaies par agression, c'est par arme blanche. Le mousse ou le casse ou le sif ou le genouillard avec le chocolat, ça ne sert à rien si les plaies parlent. Par contre, tout ce qui choque direct, c'est une radio.

C'est un problème systématique. Et nous, pour la mandibule, c'est l'orthopendogramme. Mais pour le maxillaire, c'est le scanner.

Mais comme souvent c'est associé, c'est un scanner. On demande beaucoup de scanners. Comme un traumatisme crânien.

Et d'ailleurs, c'est un traumatisme crânien facial. Et donc, on demande le scanner non seulement pour explorer la face, mais aussi pour explorer le crâne. Mais le principe du traitement, c'est comme en chromatologie.

Nous, la telle, c'est le blocage, mais l'ostéosynthèse, c'est les plaques et les vis, c'est la même chose. Mais le traumatologue ne peut pas faire de la maxillofacie. Impossible.

Impossible. Parce que sur les membres, moi j'ai fait de la chirurgie de la main, j'ai fait de la chirurgie générale, on travaille sur des os allongés et longs. Et les principes de la biomécanique orthopédique sont complètement opposés.

C'est autre chose. Ici, on travaille sur des os ronds et des fois distordus, qui ont des formes bizarres. Donc, on n'applique pas les mêmes règles d'orthopédie.

La biomécanique n'est pas la même. Nous, on réfléchit articulé dentaire. Et l'os n'est pas le même.

Notre os est très bien vascularisé et il n'est pas compact. Ici, c'est un os compact. Nous, on a affaire à un os papyrussé.

Donc, c'est des petits os très petits. C'est comme si on raccommode. Alors qu'en orthopédie, non.

C'est un alignement obligatoire. Si on n'aligne pas, la personne ne peut pas marcher. Nous, on ne peut pas aligner beaucoup.

On ne travaille pas de la même manière. C'est pour cela que l'orthopédiste ne nous touche pas. Il ne touche pas et il n'en veut pas.

C'est autre chose. Mais les règles de la ossification et les règles de l'utilisation de la vis et de la plaque sont les mêmes. On prend la vis de la même manière et on met les plaques de la même manière.

On régime de la même manière. Mais les principes et l'approche thérapeutique, elle est complètement différente. Nous ne pouvons pas faire de l'orthopédie et ne peuvent pas faire de la maxillof.

J'irais à dire, parce que moi, j'ai fait de la chirurgie de la main. Les os de la main sont petits. Ils ne sont pas traités comme un maxillof.

Ce sont des os longs et ce sont des mouvements de flexion. Donc, l'alignement, les réductions osteosynthèses d'un os long n'ont rien à voir avec les os ronds et les os monocortico-fins, papyrus. C'est autre chose.

Nous, on peut synthéser comme un os crânien. Nous, on fait par contre, dans certaines cranioplasties, l'osteosynthèse de l'os crânien. C'est un os qui est membrane.

Au niveau de l'ossification et la croissance, ça n'appartient pas à la même famille des os. C'est autre chose. Mais, comme ce que tu dis, tout traumatisme implique une exploration par l'imaginaire.

La même chose. Je vais juste regarder si vos collègues ne posent pas de questions. Est-ce qu'il n'y a pas de traitement de l'oncose? Oui, il y a un traitement de l'oncose et ça fera l'oeuvre d'un cours par le professeur Abou Chahidi, qui est médecin colonel, chef de service à l'hôpital militaire et qui fait un très, très beau cours sur l'oncose.

Il va vous montrer comment on lève l'oncose, comment on la traite et que, malgré tout, le meilleur traitement, c'est la prévention. C'est le traitement des fractures condyliennes. Je vais voir juste s'il n'y a pas de questions.

Une petite seconde. Il n'y a pas de traitement. OK.

Oui. Oui, madame. Très bien.

Donc, d'abord, comme l'attelle, on va revenir à l'ossification. Quand est-ce qu'un os, dans sa courbe, il commence à former le cal, le premier cal fibreux. Il est formé à 45 jours.

Il y a un cal fibreux suffisamment solide permettant d'enlever une attelle de jambe ou une attelle de fémur. C'est bien une immobilisation. Donc, la même chose pour la mâchoire.

Au bout de 45 jours, nous sommes autorisés, même si on ouvre la bouche et on garde encore les arcs, mais à 45 jours, on est autorisés à tout enlever, sauf si nous avons une pseudarthrose, comme en orthopédie. Ils maintiennent les attelles s'ils découvrent une pseudarthrose. Quand on fait le contrôle postopératoire à 45 jours et on fait une radio et on trouve que ça n'a pas collé, et ça, la pseudarthrose, elle n'est pas suspectée, sûre, parce que la fibrose n'est pas visible sur la radio, mais sur les mouvements.

On va trouver que la mandibule est mobile. On est obligé de revenir et de renforcer l'immobilisation. Alors, pour l'oncologie, oui, on a des patients qui, sans oncologie, je ne dis pas sans oncologie, l'oncologie, c'est complètement figé, qui limite l'ouverture buccale.

Bien sûr, c'est dire l'intérêt de la rééducation postopératoire. Dès qu'ils sont opérés à J plus 7, on leur met les élastiques de propulsion et ils se mettent à ouvrir fermé. On leur donne du chewing-gum pour mobiliser, pour ne pas être dans l'oncologie.

Et cela n'empêche que dans certains cas, on trouve des oncologies. Et si le patient commence à limiter et que l'os se forme, on opère et on libère l'oncologie. Je vais aller jusqu'à la conclusion.

Donc, en conclusion, les fractures de la mandibule sont fréquentes. Elles relèvent actuellement d'un traitement chirurgical ou orthopédique. Le risque essentiel, c'est celui d'une fracture méconnue du condyle.

Malheureusement, nous, non aux maltraités, conduisons à l'oncologie temporomandibulaire qui constitue une véritable infirmité. Tout impact sur le montant doit faire rechercher une fracture mandibulaire, soit par un orthopantomogramme ou bien par un scanner. Donc, je vous libère.

Il est 15h45. Donc, je vous laisse le repos. Il nous reste deux heures de cours.

C'est un vendredi, je crois, après-midi prochain. Je vais voir si je pourrais le faire. Sinon, je le laisse pour la semaine d'après.

Pour vous faire deux heures sur les cancers de la cavité buccale, j'essaierai de le faire en une heure et demie et de vous faire autre chose dans le programme qui ne sera pas comptabilisé dans le cours et qui sera bien sûr aussi intéressante que le reste. Allez, bon après-midi.